

Przeciwp przeniesienie *jako narzędzie*

Emocjonalna reakcja terapeuty na pacjenta to nie zakłócenie do stłumienia, lecz najbardziej bezpośrednia informacja o wewnętrznym świecie pacjenta — jeśli zostanie zrozumiana.

CZAS: 30 min · poziom zaawansowany Stale — co sesja; superwizja; psychoterapia własna

ŹRÓDŁO: Heimann (1950); Racker (1968)

JAK UŻYWAĆ

Traktujesz własną reakcję na pacjenta (przeciwp przeniesienie, ang. *countertransference*) jako dane diagnostyczne. Zapisujesz po sesji, co czujesz/-aś (znużenie, irytacja, pociąg, chęć ratowania), identyfikujesz typ (Racker): **konkordantne** — czujesz to, co pacjent (smutek przy pogrążonym w żałobie); **komplementarne** — czujesz się jak wewnętrzny obiekt pacjenta (np. zmuszony/-a do krytyki, jak jego krytyczna matka). Nie działasz z impulsu — badasz go i omawiasz w superwizji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tłumienie reakcji („powinienem być neutralny”) albo działanie na nie bez świadomości traci cenną informację i grozi szkodą. Zrozumienie typu pozwala odróżnić, co pacjent przywołuje z Twojego świata (odgrywanie terapeuty), od tego, czego możesz się dowiedzieć o jego świecie (diagnostyka). Ponieważ terapeuta ma też **własne** przeniesienia mieszające się z reakcjami na pacjenta, kluczowe są psychoterapia własna, superwizja i samoobserwacja. Nieodniesione przeciwp przeniesienie jest jednym z najczęstszych źródeł naruszeń granic.

01

Zapisz własne reakcje

Po sesji zanotuj, co się w Tobie pojawiło. To materiał, nie wstyd.

MOJE REAKCJE W TEJ SESJI

02

Zidentyfikuj typ i hipotezę

Czy czuję się *jak pacjent* (konkordantne), czy *jak jego wewnętrzny obiekt* (komplementarne)? Hipotezy: znużenie → izolacja afektu pacjenta; irytacja → pasywno-agresywna obrona; pociąg → erotyzowane przeniesienie lub reakcja ratunkowa. Sprawdź też: co przywołuje to we mnie z mojego życia?

TYP

— *konkordantne* / *komplementarne*

CO TO MÓWI O ŚWIECIE PACJENTA

03 ✗ Nie działaj z impulsu

Jeśli chcesz dać radę, pocieszyć, obronić się albo zrobić wyjątek — zatrzymaj się. To znak, że pole pracuje. Zapisz impuls, którego nie wykonasz.

IMPULS DO POWSTRZYMANIA

04 ✨ Omów w superwizji, czasem użyj w interpretacji

Silne reakcje omawiaj w superwizji — kolega „z zewnątrz” widzi wyraźniej. Czasem, gdy hipoteza jest bezpieczna, można jej użyć ostrożnie: „zauważam, że gdy opowiada Pani o matce, czuję... — zastanawiam się, czy to coś mówi o Pani doświadczeniu?”

DO OMÓWIENIA W SUPERWIZJI

Klucz: silne przeciwprzeniesienie (zwłaszcza erotyzowane lub agresywne) jest sygnałem, nie faktem o pacjencie — nie działaj na jego podstawie, badaj je. Dbaj o siebie: psychoterapia własna, superwizja i rozsądne obciążenie. Superwizja nie jest luksusem, lecz obowiązkiem etycznym.